

MANEJO DEL PACIENTE PORTADOR DE TRAQUEOSTOMÍA EN URGENCIAS

Carles Heredia Llinàs, Fernanda Rodríguez Hott, Alejandro Löwy Benoliel.

¡RECUERDA!

- El diagnóstico de las Urgencias relacionadas con el uso de traqueostoma se diagnostican mediante ANAMNESIS y EXPLORACIÓN.
- La prioridad en todo momento debe ser MANTENER LA VÍA AÉREA.
- Muchos motivos de consulta pueden prevenirse mediante CUIDADOS EXQUISITOS, INFORMACIÓN e HIGIENE.

INTRODUCCIÓN

La traqueostomía o traqueotomía es una intervención quirúrgica que consiste en abrir una comunicación directa entre la pared anterior de la tráquea y la piel del cuello, creando una vía aérea artificial; este orificio recibe el nombre de “traqueostoma”. Una vez creado, el traqueostoma tiende a cerrarse de manera espontánea, por lo que es necesario el uso de una cánula (que puede estar hecha de diversos materiales) para estabilizarlo, facilitar la limpieza y maximizar la comodidad del paciente y del personal sanitario.

El principal objetivo de la traqueostomía es facilitar una vía aérea segura. Existen varias indicaciones para realizar este procedimiento, como el facilitar una vía para ventilación mecánica prolongada, crear una vía de ventilación en caso de obstrucción o mal manejo de secreciones o riesgo de aspiración.

Según el paciente y la indicación, la necesidad de la traqueostomía será permanente o temporal. En cualquier caso, un paciente portador de traqueostoma requiere unos cuidados particulares, y se enfrenta a una serie de riesgos de complicaciones que pueden llevarle a consultar en Urgencias.

Cánulas de traqueostomía

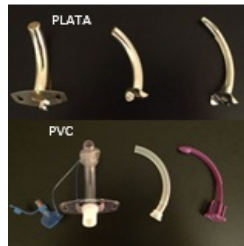
La cánula es un tubo que se introduce en la tráquea a través del traqueostoma y lo mantiene permeable. Según el material, distinguimos entre cánulas de PVC (compatibles con sistemas de ventilación mecánica), de plata o de silicona.

Las cánulas que se utilizan inicialmente tras la realización de una traqueostomía son siempre de PVC. Existen dos tipos principales de modelos: con balón o pneumotaponamiento, que consiste en un manguito hinchable situado abrazando el extremo distal del tubo que protege la tráquea de aspiraciones; o sin balón.

Las cánulas de PVC y de plata constan habitualmente de dos componentes: un tubo endotraqueal propiamente dicho, y un “macho” o cánula interna, que tiene un calibre ligeramente inferior al de la cánula y se coloca en su interior. En caso de obstrucción o

suciedad, el cambio únicamente del macho permite restituir la vía aérea sin necesidad de extraer la cánula en su totalidad. Existe también un tercer componente, la guía o fiador, que, al igual que el macho, se coloca en el interior de la cánula, y, mediante una punta afinada y roma que sobresale por el extremo distal, facilita la correcta colocación en el interior de la tráquea. Solo se utiliza el fiador en los momentos de cambio de cánula. Las cánulas de silicona suelen estar formadas por un único componente.

Existen numerosos tipos de cánulas, adaptadas a pacientes con diversas necesidades. Los pacientes portadores de traqueostoma permanente pueden ser usuarios de cánulas fenestradas, que permiten hablar con ella puesta; filtros para humidificar el aire, etcétera.



DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE URGENCIAS HABITUALES

Disnea y obstrucción

La obstrucción de la cánula o de la tráquea altera o impide el flujo ventilatorio, y es un motivo habitual de consulta en Urgencias. La causa más habitual de taponamiento es el acúmulo de secreciones, que se secan en contacto con el aire y forman un tapón; la incapacidad de humidificar el aire y la alteración en el flujo mucociliar que la traqueostomía produce predisponen a la formación de tapones de moco.

En algunos casos, este tapón puede estar formado por restos hemáticos (más frecuentes en el periodo posoperatorio inmediato, dado el riesgo de sangrado). También es necesario descartar la presencia de cuerpos extraños en la vía aérea.

- **Diagnóstico:** El paciente refiere disnea y sensación de oclusión en la vía aérea. En casos graves, la oclusión puede ser completa. Durante la exploración, se evidencia un flujo de aire a través de la cánula disminuido.
- **Tratamiento:** Debe retirarse el macho de la cánula y comprobar si está ocluido; si es así, debe colocarse un nuevo macho limpio. En caso de que la cánula sea de una pieza, o de que el macho no esté ocluido, debe retirarse la cánula y aspirar mediante una sonda a través del traqueostoma: es habitual notar la obstrucción como un tope de consistencia dura. Debe pedirse al paciente que expulse el tapón tosiendo, ayudando mediante la instilación directa de suero fisiológico o mucolítico (p.ej.: mesna) a través del traqueostoma (no más de 1cc de una vez) o su administración en aerosoles, y la aspiración. La expulsión del tapón resuelve el cuadro.

Ante la sospecha fundada de cuerpo extraño en la tráquea, es necesaria la valoración por un especialista en ORL.

Es importante tener en cuenta que un cuadro de disnea y obstrucción respiratoria puede no estar causado por un problema a nivel de tráquea o traqueostoma, por lo que exige un

diagnóstico diferencial con procesos bronquiopulmonares (p.ej.: reagudización de EPOC, neumonía...).

Aspiración y disfagia

El paciente traqueostomizado presenta habitualmente problemas para la deglución tanto de sólidos como de líquidos. El uso de cánula dificulta o impide el ascenso de la laringe durante la deglución; además, el paciente traqueostomizado puede presentar otros factores que empeoren o condicionen disfagia (edad avanzada, enfermedades neurológicas, periodos largos de afagia...).

- **Diagnóstico:** El paciente refiere dificultad para deglutir sólidos o líquidos, con o sin atragantamientos. Puede haber salida de alimentos por la cánula o el estoma. Puede haber signos y síntomas de complicación (neumonía broncoaspirativa).
- **Tratamiento:** Debe recomendarse una dieta con uso de espesantes, evitando dobles texturas y procurando masticar y tragar en un ambiente tranquilo y sin prisas, en sedestación y acercando el mentón al pecho en el momento de deglutir. Es conveniente mantener el balón desinchado o usar una cánula sin él, puesto que dificulta la deglución. Sin embargo, mantener el balón hinchado evita el paso de alimentos a la vía aérea en caso de aspiración, y es conveniente usarlo si el paciente toma pequeños sorbos varias veces al día. En caso de imposibilidad para deglutir o evitar la aspiración, debe evitarse la alimentación oral y consultar con el especialista para estudio completo de deglución.

La mayoría de pacientes mejora en su deglución a medida que se acostumbra al traqueostoma. La principal complicación de este cuadro es la neumonía broncoaspirativa. En caso de diagnosticarse, deberá suspenderse la alimentación oral y establecer el tratamiento apropiado.

La fístula traqueoesofágica es un cuadro infrecuente pero grave que cursa con dolor cervical o retroesternal, especialmente durante la deglución, salida de alimentos por el estoma y broncoaspiración, y puede complicarse con una mediastinitis aguda. Sus causas, en relación con la traqueostomía, incluyen úlceras por decúbito causadas por la cánula, lesiones durante la cirugía, infecciones, pinzamiento entre cánula y sonda nasogástrica o lesión por cuerpos extraños o cáusticos. En caso de sospecha, debe referirse inmediatamente al especialista. Su tratamiento es quirúrgico.

Hemorragia

La hemorragia a través del traqueostoma es un motivo de consulta habitual. Las causas posibles son numerosas, y es necesario en un primer lugar determinar la gravedad de la hemorragia y su origen aparente. La mayoría de ocasiones, el sangrado tiene relación con la propia intervención, y se corresponde a un manchado leve de la herida. En pacientes intervenidos mucho tiempo atrás, el origen del sangrado suele ser una lesión en el estoma o la tráquea de aparición reciente. Hay que tener en cuenta que una hemorragia en la vía aerodigestiva superior o en el pulmón causarán habitualmente la salida de sangre a través de la cánula, ya sea por la caída de la misma por gravedad o impulsándola hacia la tráquea al toser. Siempre hay que tener presentes estos posibles orígenes, en los que el traqueostoma es un hecho incidental.

- **Diagnóstico:** El paciente refiere la salida de sangre o restos hemáticos a través de la cánula o el traqueostoma. Puede haber o no un antecedente de traumatismo o lesión por cuerpo extraño. El sangrado puede evidenciarse en el momento de la exploración, o que solo se encuentren restos hemáticos. Es necesario retirar la cánula e inspeccionar concienzudamente los bordes del traqueostoma y las paredes de la tráquea en busca de lesiones que justifiquen la hemorragia. También debe explorarse la vía aerodigestiva superior) en busca de epistaxis o sangrados a ese nivel, y valorar la posibilidad de sangrado de origen broncopulmonar. Con el balón hinchado, la salida de sangre a través de la cánula es sugestiva de hemorragia distal, y la salida alrededor de ella lo es de sangrado en vía superior o periostomal.
- **Tratamiento:** En caso de sangrado copioso, es necesario proteger la vía aérea colocando una cánula de PVC con balón e hincharlo, de tal manera que se evite la caída de sangre a la vía aérea inferior; acto seguido, contactar con el especialista y e intentar estabilizar al paciente si fuera necesario. Sangrados de escaso débito a través de pequeñas erosiones o lesiones benignas en traqueostoma (ver más adelante) pueden ser controlados aplicando nitrato de plata. Los restos hemáticos no justificados por la exploración del área pueden haberse originado a otro nivel. En caso de que persistan dudas sobre el origen de la hemorragia, debe contactarse con el especialista para exploración más concienzuda (p.ej.: fibrolaringoscopia).

Lesiones periostomales

La exposición constante del traqueostoma y las paredes de la tráquea a manipulaciones y posibles factores lesivos condiciona un riesgo para la aparición de pequeñas lesiones cutáneas y mucosas, que suelen cursar con dolor, molestias, prurito, dificultad para el cambio de cánula y hemorragias leves.

- **Diagnóstico y tratamiento:** El paciente refiere alguno de los síntomas antes mencionados, o él mismo o un cuidador han visto una lesión de reciente aparición. Es necesario examinar a vista los bordes del estoma y la tráquea. Son lesiones frecuentes:
 - **Granuloma:** Crecimiento vegetante de aspecto rojizo y propenso al sangrado, no doloroso, especialmente en el borde inferior. Causado por la fricción de la cánula y la humedad. Se cauteriza con nitrato de plata, se aplica pomada antibiótica y se asegura que la cánula está bien fija y es del tamaño apropiado.
 - **Dermatitis:** Piel irritada, descamada, con prurito o dolor. Causada por la maceración debida al acúmulo de secreciones. Deben indicarse limpieza frecuente y sequedad.
 - **Infección:** Puede haber una sobreinfección del estoma o la herida. Inflamación intensa y dolorosa de la zona. Tratar, según gravedad, con antibiótico tópico+/- sistémico. Contactar con especialista si muy extensa.
 - **Úlcera por presión:** Debida a la cánula. Muy dolorosa, en piel o pared traqueal. Hay indicar cambios frecuentes de cánula y de posición, y limpieza de la zona. Puede usarse crema cicatrizante o antibacteriana para prevenir sobreinfección.

Pueden aparecer granulomas en la pared anterior de la tráquea, inferiormente al traqueostoma, debidas a la fricción por la cánula ("a punta de cánula"). La correcta exploración debe realizarse mediante espejito o fibroscopio.

Ante la presencia de lesiones sospechosas de malignidad (especialmente en pacientes con historia de cáncer en cabeza y cuello), debe remitirse rápidamente al especialista.

Problemas en el manejo de la cánula

El cuidado del traqueostoma exige manejar de manera autónoma la cánula: conocer sus componentes y ser capaz de su cambio y limpieza. Son problemas habituales:

- **Estenosis:** Un periodo de 60-90 minutos sin cánula puede condicionar que el estoma empiece a cerrarse, causando estenosis. El tratamiento con radioterapia también puede condicionar estenosis. Debe procederse a la dilatación escalonada del estoma mediante cánulas de tamaño creciente, hasta poder colocar de del tamaño apropiado. En casos de que esto sea imposible, se colocará una cánula más pequeña. En ningún caso debe permanecer el estoma sin cánula.
- **Falsa vía:** Es posible crear, sobre todo si se realizan los cambios sin cuidado, una “falsa vía” en el traqueostoma: un espacio anatómico subcutáneo que se abre paso distalmente, siguiendo la posición de la tráquea, en fondo de saco y en el que se puede introducir la cánula. Es importante realizar los cambios visualizando la entrada a la tráquea, y comprobando siempre que haya buen paso de aire. En caso de que se sospeche la presencia de una falsa vía de gran tamaño, contactar con el especialista.
- **La cánula se mueve mucho o se sale:** Deben evitarse movimientos bruscos, y mantener la cánula bien atada en todo momento. Debe ajustarse el tamaño de la cánula al del cuello del paciente y el de su traqueostoma.



BIBLIOGRAFÍA

- Libro virtual de formación en ORL. Madrid: Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Web SEORL.
- Soto Campos, J. y Acosta Bazaga, E. (2016). Manual de diagnóstico y terapéutica en neumología. Majadahonda, Madrid: Ergón.
- Caravaca García A. (2014) Manual de manejo de la traqueotomía para sanitarios y pacientes. Albacete: LiberLIBRO.com
- Dawson, D. (2014). Essential principles: tracheostomy care in the adult patient. Nursing in Critical Care, 19(2), pp.63-72.